

INCAPACIDADES.AI PRESENTA

RETO DE AUTOMATIZACIÓN

De PDF a Radicado

*¿Cómo hacemos que una incapacidad médica pase de un PDF
a un radicado oficial — con trazabilidad completa para potenciar las habilidades de las
personas de talento humano— integrado a la plataforma existente?*

Brief para equipos participantes · Incapacidades.ai · 2026

01 / EL DOLOR

**Una incapacidad laboral llega como un PDF.
Sale — si todo va bien — como un número de radicado en el portal de una EPS.
Entre esos dos puntos hay un proceso que hoy depende completamente de personas.**

Alguien abre el PDF, lee los datos, busca al trabajador en el sistema, consulta manualmente en ADRES si la EPS que figura en el documento es la correcta para esa fecha, verifica al médico en RETHUS, entra al portal web de la EPS, llena el formulario, adjunta el archivo, espera la respuesta y anota el radicado. Si algo falla — el portal cae, el archivo pesa demasiado, el médico no aparece — el proceso se detiene y empieza de nuevo.

Ese flujo se repite decenas de veces al día, por incapacidad, por empresa, por gestor. No escala. No tiene auditoría real. Y cada error tiene un costo: glosas, incapacidades no radicadas a tiempo, cartera que no se recupera.

Los tiempos de espera, los errores de digitación, las glosas, la carga operativa — todos son síntomas del mismo problema: un proceso crítico que vive en la cabeza de las personas.

02 / LOS HUMANOS DETRÁS DEL PROBLEMA

Tres personas. Un mismo problema de raíz.

V Valentina Gestora de incapacidades	Tiene 35 incapacidades en cola. Abre cada PDF, copia datos manualmente al portal de la EPS, consulta ADRES en otra pestaña, revisa RETHUS en otra. Si el portal de la EPS lanza error, no sabe si el radicado quedó o no. Repite hasta que funciona. Todo el día.
A Andrés Coordinador de operaciones	No sabe en tiempo real cuántas incapacidades están radicadas, cuántas fallaron ni cuánto lleva cada una. El seguimiento vive en un Excel que nadie actualiza igual. Cuando una empresa cliente pregunta, tiene que llamar a Valentina.
L Laura Empresa cliente	Paga el servicio de gestión de incapacidades. Necesita saber qué pasó con la incapacidad de su empleado. No tiene visibilidad. Llama. Le dicen que están en eso. Si la radicación llega tarde, la EPS no paga y la empresa asume el costo.

03 / LO QUE YA SE INTENTÓ — Y POR QUÉ NO BASTA

✗ Excel de seguimiento — sin alertas, sin estados en tiempo real, sin auditoría → no basta.

✗ Macros locales en el PC del gestor — sin trazabilidad, rompen con cada actualización del portal → no basta.

- ✗ Más gestores — más inconsistencia, no menos → no basta.
- ✗ Checklist de validación manual — depende de que alguien lo siga → no basta.
- ✗ Módulo dentro de Laravel — Laravel no debe ejecutar automatización de larga duración → no basta.

El siguiente intento tiene que ser estructuralmente distinto.

04 / LOS DATOS QUE CUENTAN LA HISTORIA

+30 min	8 EPS	0 visib.
POR INCAPACIDAD	CON PORTALES	EN TIEMPO REAL
tiempo promedio de gestión manual	distintos, cada uno con su formulario y reglas	sobre el estado de radicación para la empresa

05 / LA PREGUNTA DEL RETO

¿Cómo logramos que una incapacidad médica — que llega como un PDF — quede radicada ante la EPS correcta de forma automática, con validación en fuentes oficiales, evidencia del proceso y estado visible en tiempo real para todos los involucrados, sin reemplazar la plataforma que ya existe?

No es un problema de interfaz. Es un problema de orquestación, validación e integración.

06 / DIRECCIONES QUE PUEDEN EXPLORAR

No hay una sola respuesta correcta. Estas son puertas abiertas:

Extracción inteligente Leer documentos médicos en PDF, JPG o PNG con precisión, independiente del formato, la calidad del escaneo o el tipo de incapacidad.	Validación en fuentes oficiales Conectar con ADRES y RETHUS para verificar automáticamente la EPS activa y el estado del médico a la fecha del evento.
Automatización de portales Navegar los portales web de las EPS como lo haría un humano, pero sin intervención manual y con captura de evidencia.	Orquestación de procesos Coordinar múltiples incapacidades en paralelo, con reintentos ante fallos y estado individual por caso.
Trazabilidad operativa Registro de cada paso del proceso — extracción, validación, radicación — con evidencia descargable para auditoría y seguimiento.	Visibilidad en tiempo real Que Andrés vea el estado sin llamar a Valentina. Que Laura sepa sin llamar a Andrés.
Manejo de errores del portal Detectar cuando el portal EPS falla, cuándo el archivo supera el límite permitido y cómo derivar el caso a revisión humana sin perderlo.	Escalabilidad por EPS Diseñar para que agregar una nueva EPS sea predecible, no un proyecto nuevo cada vez.

Los mejores equipos combinarán varias. No hay puntos extra por complejidad si la solución no elimina la carga manual.

07 / CÓMO SE VE EL ÉXITO

No medimos features. Medimos si el problema desapareció.

- ✓ Un PDF de incapacidad se convierte en datos estructurados sin que Valentina toque un teclado.
- ✓ La EPS correcta para la fecha del evento se determina automáticamente, sin consulta manual en ADRES.
- ✓ El médico emisor se verifica en RETHUS sin que nadie entre a esa página.
- ✓ El radicado llega al portal oficial de la EPS y el número queda registrado automáticamente.
- ✓ Si el proceso falla, hay evidencia y el caso queda en revisión humana — no desaparece.
- ✓ Andrés ve el estado de cada incapacidad sin preguntarle a nadie.
- ✓ Laura recibe confirmación del radicado sin llamar.
- ✓ Agregar una nueva EPS al sistema no requiere reescribir la lógica central.

Si tu demo logra esto, el cómo lo decides tú.

08 / ESCENARIOS PARA LA DEMO

Resuelve al menos 3 de estos escenarios con tu solución.

EXTRACCIÓN	Un PDF de incapacidad con baja calidad de escaneo. ¿Qué datos logra extraer tu solución y con qué nivel de confianza?
VALIDACIÓN ADRES	La EPS que figura en el documento no coincide con la que devuelve ADRES para la fecha de inicio. ¿Cómo lo detecta y qué hace?
VALIDACIÓN RETHUS	El médico emisor figura en RETHUS como inhabilitado. ¿Cómo lo notifica y qué sugiere?
RADICACIÓN EPS	La incapacidad está lista para radicar ante Compensar. El archivo pesa 950 KB y el límite de Compensar es 900 KB. ¿Qué hace?
TRAZABILIDAD	Una empresa pregunta: '¿qué pasó con la incapacidad del empleado 123456 del 10 de abril?' ¿Qué puede mostrar tu solución?

09 / CONTEXTO TÉCNICO Y REGLAS

La plataforma existente está construida en Laravel. Esa plataforma no se reemplaza, se extiende. El reto es construir el componente que automatiza lo que hoy hacen las personas, conectándose a Laravel por HTTP.

STACK SUGERIDO	NO NEGOCIABLES
Lenguaje: Python API: FastAPI	• La solución debe desplegarse como microservicio independiente — no como módulo dentro de

RPA: Playwright o Selenium OCR: pytesseract / AWS Textract / visión IA Datos: Suministrados por el equipo organizador El stack es sugerencia, no cárcel. Si tu solución resuelve mejor el dolor con otra herramienta, preséntala.	Laravel. Esto es lo que permite integrarla a la plataforma. • Toda comunicación con Laravel por HTTP. El microservicio no escribe directo en la BD. • Trazabilidad: cada acción debe poder auditarse. • Privacidad: credenciales EPS nunca en logs.
--	--

10 / ENTREGABLES

Lo que esperamos ver el día del pitch.

01 Demo funcional Algo que se pueda usar, no solo mostrar en slides. Al menos 3 escenarios de la sección 08 resueltos.

02 Pitch de 5 minutos Qué dolor resuelves, cómo lo resuelves y qué aprendiste.

03 Diagrama de arquitectura Cómo se conecta tu solución con Laravel. Qué corre dónde.

04 Visión más allá del MVP Qué no construiste pero pensaste: más EPS, más automatización, más inteligencia en la extracción.

*"La automatización en Incapacidades.ai
no reemplaza al gestor — multiplica su capacidad."*

El reto está abierto. La forma de resolverlo, no.

INCAPACIDADES.AI · RETO DE AUTOMATIZACIÓN · 2026